

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: KEVIN ALEJANDRO VIZCAINO VILLERO	H.C: 1066872807
EDAD: 17 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 22/10/2007
ESCOLARIDAD: Segundo semestre de licenciatura en educación física y deporte	FECHA DE EVALUACIÓN: 15/10/2025
DIRECCION: MZ 72 CASA 11 A- VILLA DARIANA 2	CORREO: Inpao.amor@hotmail.com
EPS: Particular	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega
ACOMPAÑANTE: Madre	CELULAR: 3005012634

2. MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, el detonante fue el comportamiento de él, que no obedece las reglas de la case, tuvo en episodio del tema del vaper.

3. ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde hace dos años caracterizado por dificultades de comportamiento, no llega temprano a casa cuando sale hacer deporte, el comportamiento de la casa es diferente al de la casa, la madre agrega que no le tiene confianza, poco dialoga con ella, le cuesta la comunicación, la fluidez verbal, no quiere compartir en reuniones familiares, se aísla al cuarto, cuando están de paseo presenta similar comportamiento. Presenta adición en los videos.

Selectivo para comer, (como pollo en alitas, no come carne, cerdo, pescado).

Madre lo describe como tímido, sin embargo en situación de hurto del celular hace aproximadamente 5 años, respondió de manera activa saliendo detrás de los ladrones sin medir el peligro.

Hace aproximadamente 14 años los padres se separaron, la madre se siente culpable por la ruptura de la relación.

4. ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: No reporta.

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

5. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: Primo en segundo grado con TDAH.

6. CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, inadecuada higiene postural, reticente, poco colaborador, lenguaje concreto, necesidad de instigación, orientado alo y auto psíquicamente, bradilalico, bradipsiquico, tendencia distractica, no quejas de memoria, no alteraciones de sueño, no



alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia.

7. PRUEBAS APLICADAS

Se realizó prueba NEUROPSICOLÓGICA Escala de inteligencia de Wechsler para adultos, WAIS – cubos, búsqueda de símbolos, claves, dígitos, dígitos en orden directo, inverso y creciente, Semejanzas, comprensión, información, vocabulario, matrices, aritmética, rompecabezas visuales. WISCOSIN.

 WAIS-IV ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS® - CUARTA EDICIÓN				
ÍNDICE	SUB-PRUEBA	PN	PE	DESCRIPCIÓN
Comprensión verbal (ICV)	Semejanzas (SE)	19	9	Promedio
	Vocabulario (VB)	24	8	Promedio
	Información (IN)	9	10	Promedio
Razonamiento Perceptual (IRP)	Diseño con Cubos (DC)	36	9	Promedio
	Matrices (MT)	16	9	Promedio
	Rompecabezas Visuales (RV)	12	9	Promedio
Memoria de trabajo (IMT)	Retención de dígitos (RD)	20	8	Promedio
	Aritmética (AR)	8	6	Medio Bajo
Velocidad de Procesamiento (IVP)	Claves (CL)	60	9	Promedio
	Búsqueda de símbolos (BS)	34	11	Promedio
ÍNDICES PRIMARIOS	S. de PE	PCo		DESCRIPCIÓN
Comprensión verbal	27	92		Promedio
Razonamiento Perceptual	27	93		Promedio
Memoria de Trabajo	14	85		Medio Bajo
V. de procesamiento	20	100		Promedio
Cociente intelectual	88	90		Promedio

Rango normal establecido para cociente intelectual (90), alteraciones en funciones ejecutivas – Memoria de trabajo.



RANGO DE PERCENTILES DE PRUEBA DE INTELIGENCIA

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. El paciente obtuvo un CIT de **90**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WAIS IV, con **capacidad general PROMEDIO**, estableciendo una puntuación muy por debajo del rango y promedio para su edad, escolaridad y grupo etario.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **92**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **93**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos construccionales, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **85**, se clasifica con una capacidad general **medio bajo**, estando 1 rango por debajo de lo esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental.

Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **100**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para parear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.



PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE WISCONSIN

Mide organización, planificación, seguimiento de secuencia, flexibilidad, el cambio de tarea, o la inhibición, mantenimiento del principio, uso del feedback, capacidad para modificar estrategias incorrectas, resolución conceptual de problemas.

WCSTw: Resultados

Indica "nº ítem: tecla pulsada/Acierto(+) o Error(-)/Respuesta según Color/Forma,..."

1: 3/-/D-/	33: 4+/CF-/	65: 3/-/D-/	97: 4/-/CF-/
2: 3/-/F-/p	34: 3+/CF-/	66: 4+/N-/	98: 3/-/CF-/
3: 3/-/D-/	35: 2+/CF-/	67: 3/-/D-/	99: 1+/N-/
4: 3/-/D-/	36: 3+/C-/	68: 1+/CN-/	100: 2/-/D-/
5: 3/-/D-/	37: 4+/CF-/	69: 2/-/CF-/	101: 4/-/CF-/
6: 3+/CF-/	38: 3+/CN-/	70: 1+/N-/	102: 3+/CN-/
7: 3/-/D-/	39: 2-/C-/	71: 4+/CN-/	103: 1+/N-/
8: 3/-/N-/	40: 3+/F-/	72: 3+/N-/	104: 4+/CN-/
9: 3/-/F-/p	41: 1+/CFN/	73: 4+/N-/	105: 1+/CFN/
10: 3+/C-/	42: 2+/F-/	74: 2+/N-/	106: 2/-/F-/p
11: 4+/C-/	43: 4+/FN-/	75: 3/-/D-/	107: 3/-/C-/
12: 1+/CF-/	44: 1+/F-/	76: 1/-/CF-/	108: 2+/CN-/
13: 3/-/F-/p	45: 2+/F-/	77: 2+/N-/	109: 3+/N-/
14: 3+/C-/	46: 3+/CF-/	78: 1+/N-/	110: 2+/N-/
15: 2+/C-/	47: 4+/CF-/	79: 3+/N-/	111: 4/-/CF-/
16: 4+/CFN/	48: 1+/F-/	80: 4+/CFN/	112: 1/-/F-/p
17: 1+/C-/	49: 3+/F-/	81: 2+/FN-/	113: 3/-/F-/p
18: 3+/CN-/	50: 2-/F-/	82: 3+/CN-/	114: 2/-/F-/p
19: 1+/CF-/	51: 3/-/D-/	83: 2/-/D-/	115: 1+/FN-/
20: 3+/C-/	52: 4/-/D-/	84: 4/-/F-/p	116: 3+/N-/
21: 2/-/FN-/	53: 2+/N-/	85: 3/-/D-/	117: 2+/N-/
22: 2+/C-/	54: 1/-/F-/p	86: 2/-/C-/	118: 4+/N-/
23: 3+/C-/	55: 2/-/D-/	87: 2+/FN-/	119: 1+/N-/
24: 4+/C-/	56: 3+/N-/	88: 3+/N-/	120: 3+/N-/
25: 2/-/F-/p	57: 4/-/D-/	89: 4+/N-/	121: 2+/N-/
26: 3+/C-/	58: 3-/C-/	90: 2+/N-/	122: 1+/FN-/
27: 3/-/FN-/	59: 2/-/D-/	91: 3+/FN-/	123: 3+/FN-/
28: 1+/C-/	60: 3/-/D-/	92: 4+/FN-/	124: 2+/CN-/
29: 2+/CFN/	61: 2/-/F-/p	93: 2+/CFN/	125: 4+/CN-/
30: 1+/CN-/	62: 4/-/D-/	94: 3/-/F-/p	126: 3+/CFN/
31: 2+/C-/	63: 1/-/CF-/	95: 2/-/C-/	127: 2/-/N-/
32: 2+/CF-/	64: 2/-/C-/	96: 2/-/CF-/	128: 3/-/F-/p

W.C.S.T. A. Estévez-González, 2001

Datos Personales

KEVIN ALEJANDRO VIZCAINO VILLERO
 Fecha : 15/10/25
 Sexo : v
 Edad : 17 años
 Lateralidad : Diestro/a
 Escolaridad : 12 años
 Observaciones no especificadas

Resultados

INTENTOS Utilizados.....: 128
 ACIERTOS Totales.....: 77
 ERRORES Totales.....: 51 (39%)
 Errores Perseverativos...: 13 (10%)
 Errores NoPerseverativos: 38 (29%)
 Respuestas Conceptuales : 70 (54%)
CATEGORIAS.....: 3
 Nº Intentos 1ª categoría: 37
 Errores Manten. del Set : 4
 Aprendiendo a Aprender : -7
 Tiempo medio respuesta : 1300 msec.

Características de la prueba

WCST clásico con secuencia CFND
 Nº Estímulos Prueba : 128

Imprimir Grabar Finalizar

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Resultados de evaluación:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva (aunque con tendencia distractiva).

Presenta adecuada atención auditiva, adecuada búsqueda organizada de los estímulos, así como una correcta velocidad en la ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico sin embargo la efectividad de las tareas dependerá en gran medida de la motivación y el esfuerzo.

Paciente con inadecuada capacidad de esfuerzo en la ejecución de tareas no motivantes, no prestando atención a los detalles, no se esfuerza y dirige la conducta, le cuesta inhibir los estímulos irrelevantes, le cuesta mantener la concentración cuando el grado de la tarea



aumenta, le cuesta regular su comportamiento, mantener una adecuada posición sedente, se observa agitación motora, impulsividad (atención ejecutiva).

MEMORIA: Presenta adecuada memoria ecoica e icónica, la memoria de trabajo presenta un desempeño normal acorde a lo esperado para la edad y escolaridad. Esto quiere decir, que existe adecuada capacidad para mantener una información y dar una respuesta posterior; sin embargo, puede verse afectada en caso de que tenga un mayor esfuerzo cognitivo relacionado con el control mental y capacidad atencional.

Se identifica adecuada capacidad para evocar información a corto y largo plazo de contenido auditivo verbal y visual, mejorando la evocación a partir de la repetición de las series.

Su capacidad de memoria o spam es de 7 sobre 10, observándose de forma correcta el efecto de primacía y recencia, no se observaron intrusiones, perseveración, intrusiones, con adecuada organización serial o dificultades en la narrativa del discurso.

LENGUAJE: Existe adecuada capacidad semántica, vocabulario, de información, existe adecuado seguimiento de instrucciones, comprensión (capacidad de entender y procesar el lenguaje hablado y/o en doble vía, manteniendo una comunicación efectiva comprendiendo el mundo que les rodea, adecuada fluencia lingüística en la producción oral.

No se observaron problemas articulatorios, nasalización, hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: WISCONSI, retención de dígitos y aritmética: WAIS IV. Cribado con inadecuada 1) autorregulación de impulso, aunque pose adecuada capacidad para la resolución de problemas, le cuesta 2) la inhibición y control de su conducta, sobre todo para hacer análisis de su comportamiento, le cuesta 3) planificar y organizar su conducta hacia una meta, por momentos su pensamiento y lenguaje es poco fluido con adecuada abstracción, justificado por las dificultades de mantener una adecuada conducta adaptativa, 4) se observo dificultades en la memoria de trabajo, 5) para mantener el principio, 6) altas respuestas perseverativas.

Paciente con **CIT** de **90**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WISC V con **capacidad general intelectual promedia**, sin embargo, las conductas desadaptativas, comportamiento impulsivo, poca apertura, fallas para mantener el principio, fallas atencionales, memoria de trabajo, pueden generar problemas en el desempeño escolar a pesar de no tener ninguna afectación cognitiva que limite el aprendizaje.



Se observa adecuado desarrollo de la capacidad cognoscitiva en la comprensión verbal 92 y habilidades visoespaciales de 93, lo cual establece un adecuado desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.

La memoria de trabajo, 85, se encuentran por debajo del promedio, con punto pudiendo generar dificultades en el manejo de la información a corto, plazo, en línea, siendo un punto débil normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

La velocidad de procesamiento, 100, se encuentran en el rango promedio, lo que puede establecer facilidad en las respuestas de forma rápida, efectiva y sin interferencia, punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales

COMPRESIÓN VERBAL: PROMEDIO

VISOESPACIAL: PROMEDIO

MEMORIA DE TRABAJO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: PROMEDIO

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de capacidad intelectual promedia, acompañado de perfil perturbación de la actividad y la atención + o TDAH tipo inatento de gravedad leve, con adecuadas respuestas en análisis, síntesis, razonamiento lógico, abstracción, vocabulario, semántica, adecuadas respuestas en praxias viso constructivas, viso espaciales, orientación, adecuado razonamiento lógico visual, con alto nivel de competitividad al desarrollar las tareas, pero que dependen en gran medida de la motivación y atención al estímulo presentado, al paciente le cuesta mantener información en línea y realizar tareas simultánea, sobre todo cuando debe hacer un alto esfuerzo cognitivo, en el desarrollo de la prueba Wisconsin se observaron fallas atencionales de control, presento respuestas impulsivas, baja tolerancia a la frustración, perseverativas, le costó verificar la respuesta a pesar de conocer la respuesta, le costó mantener el principio de la tarea, le costo hacer cambios conceptuales en las clasificaciones, baja capacidad metacognitiva y de metamemoria, no es consciente de la capacidad que presenta, por momentos le cuesta tener apertura cognitiva o abrirse a recomendaciones, en comparación con el desarrollo de esta prueba y el ADOS 2, se mostro mucho mas receptivo y colaborador en el desarrollo de las tareas.

Se debe hacer seguimiento ya que existe una desregulación ejecutiva colocándolo en riesgo de adicciones, deserción escolar o el desarrollo de conducta delictivas, lo cual se debe minimizar con las intervenciones.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F900 *PERTURBACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCIÓN O TDAH TIPO INATENTO.*

CIT DE 90, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL PROMEDIA.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología tres meses.



Rehabilitación cognitiva 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos de atención sostenida, mantenimiento en la tarea, motivación, metacognición, habilidades viso espaciales, fluidez, técnicas de estudio.

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde psicología que permita abordar el manejo de la frustración, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, razonamiento ético; adopción de perspectiva, desarrollo de asertividad; inoculación de estrés; auto instrucciones; habilidades de afrontamiento; autocontrol y control emocional; entrenamiento en habilidades sociales.

Recomendaciones generales:

Organización del espacio y materiales: Mantén tu escritorio ordenado y con los materiales necesarios a mano para evitar distracciones y facilitar el enfoque en las tareas.

Rutinas claras: Sigue una rutina diaria establecida, con instrucciones claras y pasos específicos para cada actividad, lo que ayuda a reducir la confusión y mejorar la atención.

Tiempos de descanso: Toma pequeños descansos entre tareas para recargar la atención. Puedes usar técnicas como la técnica Pomodoro (trabajar 25 minutos y descansar 5).

Tareas cortas y específicas: Divide las tareas grandes en partes más pequeñas y manejables, para que sea más fácil concentrarse en una cosa a la vez.

Uso de apoyos visuales: Utiliza agendas, listas de verificación, esquemas o dibujos para seguir instrucciones y mantenerse enfocado en lo que hay que hacer.

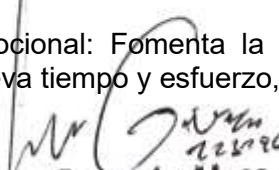
Minimizar distracciones: Busca un lugar tranquilo en el aula, si es posible, y reduce ruidos o estímulos que puedan distraer.

Técnicas de concentración: Practica ejercicios de respiración, mindfulness o atención plena para mejorar la capacidad de mantener la concentración.

Refuerzo positivo: Reconoce y celebra los esfuerzos y logros, por pequeños que sean, para motivar la atención y el interés en las tareas.

Comunicación con docentes: Mantén una comunicación abierta con los maestros para ajustar estrategias y recibir apoyo adicional cuando sea necesario.

Apoyo emocional: Fomenta la confianza y la paciencia, recordándote que mejorar la atención lleva tiempo y esfuerzo, y que está haciendo un buen trabajo.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional: 123096

